

Laringitis y Crup

1. Introducción y relevancia clínica

La **laringitis aguda**, también llamada **crup viral**, es una infección respiratoria aguda que afecta la laringe y la tráquea superior, generando **inflamación subglótica** con edema, lo que produce **obstrucción parcial de la vía aérea**.

Es una enfermedad frecuente en la infancia, especialmente entre los **6 meses y 3 años**, con un pico de incidencia alrededor de los 2 años, y constituye una causa común de consulta en urgencias pediátricas.

El agente etiológico más frecuente es el **virus parainfluenza tipo 1**, aunque otros virus respiratorios como **VRS, adenovirus, influenza y metapneumovirus humano** también pueden causarla.

El cuadro clínico es característico y se reconoce por la tríada de:

- **Tos perruna o metálica.**
- **Disfonía.**
- **Estridor inspiratorio** (especialmente nocturno).

En el **EUNACOM**, este tema es muy habitual, dado que exige identificar la urgencia respiratoria, aplicar manejo escalonado y reconocer cuándo derivar o intubar.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El crup se produce por una infección viral que causa **inflamación y edema de la mucosa subglótica**, región anatómicamente estrecha en niños pequeños.

Dado el calibre reducido de la vía aérea pediátrica, incluso un leve edema puede duplicar la resistencia al flujo de aire.

La obstrucción aérea resultante genera el **estridor inspiratorio** (ruido áspero que indica turbulencia aérea), además de **tos bitonal o metálica**.

La hipoxia y la fatiga respiratoria pueden aparecer en cuadros graves.

El edema afecta principalmente la laringe, tráquea y bronquios proximales, mientras que la epiglotis y estructuras supraglóticas suelen estar indemnes (a diferencia de la epiglottitis).

La mayoría de los casos es autolimitado, pero algunos pueden evolucionar rápidamente a obstrucción grave de la vía aérea.

3. Epidemiología

- **Edad:** 6 meses a 6 años (pico a los 2 años).
- **Sexo:** leve predominio masculino.
- **Estacionalidad:** mayor frecuencia en otoño e invierno.
- **Transmisión:** por gotas y contacto directo con secreciones respiratorias.
- **Período de incubación:** 2 a 6 días.
- **Curso típico:** 3 a 7 días, con empeoramiento nocturno.

Factores de riesgo de formas graves:

- Edad <1 año.
- Antecedente de prematurez o enfermedad pulmonar crónica.
- Inmunodepresión.
- Episodios previos severos de crup.

4. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

4.1. Cuadro clínico típico

El inicio suele ser progresivo, precedido por un cuadro catarral de vías altas (congestión nasal, rinorrea, febrícula).

A las 24–48 horas se agrega:

- **Tos perruna o metálica.**
- **Disfonía o afonía.**
- **Estridor inspiratorio** (ruido áspero audible al inspirar).
- **Dificultad respiratoria variable.**

El estridor puede presentarse solo con el llanto (crup leve) o en reposo (crup moderado a grave).

La fiebre suele ser baja o ausente.

En casos graves puede observarse tiraje supraclavicular y subcostal, taquipnea y signos de hipoxemia.

Comentario EUNACOM:

Niño de 2 años con tos metálica, disfonía y estridor nocturno sin fiebre alta → diagnóstico: **crup viral**.

4.2. Examen físico

- **Inspección:** disnea inspiratoria, uso de músculos accesorios, tiraje suprasternal o intercostal.
- **Auscultación:** estridor inspiratorio; sibilancias o roncus si hay compromiso traqueal.
- **Fiebre:** leve o ausente.

El examen de garganta **no debe realizarse con bajalenguas** en pacientes con estridor intenso o dificultad respiratoria, ya que puede precipitar laringoespasma o paro respiratorio.

4.3. Diagnóstico diferencial

Es fundamental distinguir el crup de otras causas de obstrucción alta:

- **Epiglotitis aguda:** fiebre alta, aspecto tóxico, babeo, posición en trípode, sin tos perruna. Urgencia vital.
 - **Traqueítis bacteriana:** fiebre alta, mal estado general, secreciones purulentas, escasa respuesta a adrenalina.
 - **Cuerpo extraño laríngeo:** inicio súbito, sin fiebre, con episodios de tos asfíctica.
 - **Absceso retrofaríngeo:** fiebre alta, disfagia, voz apagada, cuello rígido.
 - **Reflujo laringofaríngeo:** tos crónica y disfonía sin fiebre.
-

5. Diagnóstico

El diagnóstico de crup es **clínico**, basado en la tríada clásica (tos perruna, disfonía, estridor).

Los exámenes complementarios no son necesarios en la mayoría de los casos.

Exámenes complementarios (sólo en casos atípicos o graves):

- **Oximetría de pulso:** monitoriza saturación (SatO_2 >94% en leves).
 - **Radiografía lateral de cuello:** puede mostrar estrechamiento subglótico ("signo del campanario"), aunque no es rutinaria.
 - **Hemograma y PCR:** solo si se sospecha coinfección bacteriana.
-

6. Clasificación de gravedad (MINSAL 2023 / Westley Score adaptado)

- **Leve:** tos perruna, disfonía, sin estridor en reposo, sin tiraje.
- **Moderado:** estridor en reposo, tiraje leve, buena saturación, sin agitación.

- **Grave:** estridor intenso, tiraje universal, cianosis, agitación o somnolencia, dificultad para hablar.
 - **Amenaza vital:** bradipnea, silencio respiratorio, $\text{SatO}_2 < 90\%$, compromiso de conciencia.
-

7. Manejo

7.1. Medidas generales

- Tranquilizar al niño y al cuidador: el llanto agrava la obstrucción.
 - Mantener al paciente en posición cómoda (semisentado o en brazos del cuidador).
 - Administrar oxígeno humidificado si $\text{SatO}_2 < 94\%$.
 - Evitar procedimientos invasivos innecesarios (aspiraciones, exámenes).
-

7.2. Tratamiento farmacológico (según gravedad)

A. Corticoides (tratamiento fundamental):

- **Dexametasona VO o IM:** 0,15–0,6 mg/kg dosis única (máx. 12 mg).
- Alternativas: prednisona VO 1 mg/kg o budesonida nebulizada 2 mg.
- Efecto inicia a las 2–4 horas y reduce significativamente la duración y gravedad del cuadro.

B. Adrenalina nebulizada (en casos moderados o graves):

- **Dosis:** 0,5 ml/kg de adrenalina racémica al 2,25% (máx. 5 ml) o 5 ml de adrenalina 1:1000 nebulizada.
- Produce vasoconstricción local y reduce edema subglótico.
- Efecto rápido (10–20 minutos), pero transitorio (1–2 horas).
- Requiere observación mínima de 2 horas post-nebulización.

C. Oxígeno suplementario:

- Mantener saturación $\geq 94\%$.
- Evitar flujo alto si genera ansiedad.

D. Hidratación:

- Ofrecer líquidos fraccionados.
- En casos graves, hidratación IV vigilando sobrecarga.

E. Antibióticos:

- No están indicados, salvo sospecha de traqueítis bacteriana o sobreinfección.

F. Nebulizaciones con suero fisiológico:

- Pueden aliviar síntomas leves por humidificación.
-

7.3. Criterios de hospitalización

- Estridor en reposo persistente tras tratamiento inicial.
- Necesidad de múltiples nebulizaciones con adrenalina.
- Dificultad respiratoria moderada o grave.
- $\text{SatO}_2 < 92\%$.
- Edad < 6 meses o antecedentes de enfermedad pulmonar o cardíaca.
- Compromiso del sensorio o deshidratación.
- Mala respuesta a corticoides.

Los casos graves deben manejarse en unidad de cuidados intermedios o intensivos.

Criterios de alta:

- Ausencia de estridor en reposo por > 2 horas post-tratamiento.
 - Buena saturación y tolerancia oral.
 - Control respiratorio estable.
-

8. Complicaciones

Aunque la evolución suele ser benigna, pueden ocurrir complicaciones, especialmente en menores de 1 año:

- **Obstrucción grave de la vía aérea.**
 - **Hipoxemia y paro respiratorio.**
 - **Neumonía secundaria.**
 - **Traqueítis bacteriana sobreagregada.**
 - **Insuficiencia respiratoria aguda.**
-

9. Pronóstico

El pronóstico es excelente: más del **90 % de los casos son leves y autolimitados**.

La mayoría mejora en 3–5 días con tratamiento sintomático.

La mortalidad es excepcional y se asocia a obstrucción crítica o coinfección bacteriana no tratada.

Recurrencias son comunes, especialmente en niños predispuestos o con antecedentes de atopia, aunque suelen disminuir con la edad.

10. Prevención

- **Vacunación:** contra influenza y COVID-19 reduce episodios graves.
 - **Higiene respiratoria:** lavado de manos, evitar exposición a secreciones.
 - **Evitar humo de tabaco y ambientes contaminados.**
 - **Control de enfermedades alérgicas o reflujo gastroesofágico.**
 - **Educación a los padres:** reconocer signos de alarma y consultar precozmente.
-

11. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Laringitis o crup = tos perruna + disfonía + estridor inspiratorio.
2. El diagnóstico es **clínico**, no requiere radiografía.
3. El **tratamiento esencial es dexametasona** (VO o IM).
4. **Adrenalina nebulizada** se usa solo en casos moderados o graves.
5. **No usar antibióticos ni broncodilatadores.**
6. Observar mínimo 2 horas tras adrenalina antes de alta.
7. En EUNACOM, la pregunta típica diferencia crup (tos metálica, fiebre baja) de epiglotitis (babeo, fiebre alta, posición en trípode).

Errores comunes:

- Intentar examinar la faringe con bajalenguas (puede inducir laringoespasmo).
 - Omitir corticoide en cuadros leves.
 - No observar tras nebulización de adrenalina.
 - Indicar antibióticos sin sospecha bacteriana.
 - Confundir con asma o bronquiolitis.
-

12. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **laringitis (crup)** es una infección viral aguda que produce **edema subglótico** y obstrucción respiratoria parcial.
2. Causa más frecuente: **virus parainfluenza tipo 1**.
3. Síntomas clásicos: **tos perruna, disfonía y estridor inspiratorio**.
4. El **diagnóstico es clínico**, sin necesidad de exámenes.
5. Tratamiento fundamental: **dexametasona dosis única y adrenalina nebulizada si hay estridor en reposo**.

6. No se deben usar antibióticos ni examinar la faringe con bajalenguas.
7. El pronóstico es excelente; la mayoría de los casos son autolimitados.